



PROCEDIMENTO PADRÃO Nº 010

PADRONIZAÇÃO DO MODELO
DE INTERVENÇÃO CLÍNICA

FÁBIO COELHO



SUMÁRIO

1	PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE INTERVENÇÃO CLÍNICA.....	3
1.1	OBJETIVO GERAL	3
1.2	DEFINIÇÃO OPERACIONAL	3
1.3	BASE METODOLÓGICA DO MODELO.....	3
1.4	ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA CLÍNICA.....	4
1.5	ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO	5
1.5.1	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	5
1.5.2	ÁREAS COORDENADAS POR SUPERVISORES E SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS SUPERVISONADOS	5
1.6	ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ÁREA.....	6
1.6.1	ATRIBUTOS PESSOAIS ESPERADOS	6
1.6.2	AÇÕES OPERACIONAIS.....	6
1.7	COMUNICAÇÃO ENTRE SUPERVISOR E TERAPEUTAS	6
1.8	ENCAMINHAMENTOS PARA O NÚCLEO ABA	7
1.9	INDICADORES DE QUALIDADE DO MODELO	8
1.10	EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO	8
1.11	COLETA DE DADOS E REGISTROS	9
1.12	SUPERVISÃO CLÍNICA	9
1.13	MONITORAMENTO E AJUSTES	10
1.14	GENERALIZAÇÃO.....	10
1.15	DOCUMENTOS RELACIONADOS	11
	REFERÊNCIAS.....	12



1 PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE INTERVENÇÃO CLÍNICA

1.1 OBJETIVO GERAL

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo descrever e padronizar o modelo de intervenção clínica adotado pela instituição, fundamentado no Modelo Academia do Autismo de Intervenção Singular (MAAIS), garantindo uniformidade, qualidade técnica e coerência metodológica nas práticas terapêuticas oferecidas.

1.2 DEFINIÇÃO OPERACIONAL

O MAAIS consiste em um modelo clínico sistematizado que organiza estratégias e práticas terapêuticas com base em abordagens respaldadas por evidências científicas, especialmente a Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Esse modelo estrutura fluxos de atendimento, define responsabilidades da equipe e estabelece diretrizes que orientam as decisões clínicas e institucionais. Foi desenvolvido com a finalidade de sistematizar a intervenção no ambiente terapêutico e/ou clínico, por meio da implementação de procedimentos estratégicos que reflitam os valores institucionais, alinhados à missão, visão e pilares da organização.

Este POP aplica-se a todos os terapeutas, Acompanhantes Terapêuticos (ATs), Supervisores de Área e demais membros da equipe multidisciplinar envolvidos diretamente na elaboração, aplicação e monitoramento de programas terapêuticos, com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) de cada aprendiz.

1.3 BASE METODOLÓGICA DO MODELO

A base metodológica do MAAIS reúne princípios que sustentam a prática clínica dentro do modelo, assegurando consistência teórica, efetividade e alinhamento com as diretrizes éticas e científicas. Esses elementos orientam a condução de todos os processos terapêuticos e servem como referência para a formação e supervisão das equipes.



Elemento	Descrição
Fundamento científico	O modelo fundamenta-se na ABA e em outras abordagens validadas cientificamente para intervenção com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Evidência científica	Apoiado em pesquisas publicadas, revisadas por pares e replicadas, garantindo respaldo empírico para suas práticas
Individualização	Os programas terapêuticos são planejados de forma personalizada, respeitando o perfil, as necessidades e os interesses de cada aprendiz
Transparência com a família	As famílias participam ativamente do processo terapêutico, sendo envolvidas nas decisões e no acompanhamento sistemático da evolução do aprendiz
Avaliação contínua	Os comportamentos-alvo são monitorados continuamente, com base em critérios objetivos e análise de dados, o que permite ajustes constantes no planejamento

1.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA CLÍNICA

Para garantir a aplicação efetiva do modelo, a clínica organiza sua estrutura funcional por meio de níveis hierárquicos e responsabilidades bem definidas. A seguir, apresenta-se a disposição dos cargos e suas respectivas atribuições, com vistas à manutenção da qualidade técnica e da supervisão contínua dos atendimentos:

Nível	Cargo	Atribuições principais
1	Supervisor Geral	Responsável pela gestão estratégica da clínica, validação dos modelos adotados e alinhamento institucional
2	Supervisor de Área	Coordena tecnicamente as práticas clínicas em sua especialidade, garantindo a fidelidade ao modelo
3	Supervisor Clínico ABA	Oferece direcionamento técnico específico para as intervenções baseadas em ABA, apoiando terapeutas e ATs
4	Terapeutas	Executam os planos individualizados de intervenção, registram dados e mantêm comunicação contínua com a equipe e a família
5	ATs	Oferecem apoio direto à intervenção sob supervisão, colaborando com a implementação das estratégias terapêuticas



1.5 ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO

A estrutura da intervenção no MAAIS baseia-se na atuação integrada de uma equipe multidisciplinar com expertise em desenvolvimento infantil, inclusão e atendimento a pessoas com TEA e outros atrasos do neurodesenvolvimento. O trabalho em equipe é coordenado por Supervisores de Área, que garantem o alinhamento técnico entre os profissionais e a proposta institucional.

1.5.1 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A equipe deve ser composta por profissionais qualificados nas seguintes áreas, com especialização obrigatória em ABA:

- Fonoaudiologia.
- Psicologia.
- Terapia Ocupacional.
- Psicopedagogia.
- Fisioterapia.
- Musicoterapia.
- Nutrição.

1.5.2 ÁREAS COORDENADAS POR SUPERVISORES E SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS SUPERVISIONADOS

Área	Profissionais supervisionados
Psicomotora	Fisioterapeutas, psicomotricistas, hidroterapeutas
Cognitiva	Psicopedagogos, neuropsicólogos
Comportamental	Analistas do comportamento, psicólogos
Funcional	Terapeutas ocupacionais
Linguística	Fonoaudiólogos
Nutricional	Nutricionistas
Musical	Musicoterapeutas



1.6 ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ÁREA

Os supervisores de área são responsáveis por garantir a qualidade técnica e metodológica das intervenções, alinhando as práticas clínicas às diretrizes do MAAIS. Para isso, espera-se que demonstrem competências interpessoais e operacionais específicas, conforme detalhado a seguir.

1.6.1 ATRIBUTOS PESSOAIS ESPERADOS

Competência	Comportamento esperado
Ética e respeito	Age com integridade e escuta ativa
Coerência e empatia	Mantém postura profissional equilibrada
Capacidade de síntese	Integra e interpreta diferentes informações
Comunicação eficaz	Dá e recebe <i>feedback</i> com clareza

1.6.2 AÇÕES OPERACIONAIS

Ação	Frequência	Evidência
Avaliação da carga horária de intervenção	Na avaliação e re-avaliação	Registro em reunião e relatório de evolução
Orientação sobre procedimentos e prazos	Contínua	E-mails, atas de reuniões registradas
Supervisão das avaliações em sua área	Contínua	Relatório de supervisão
Revisão de relatórios e PDIs	Semestral	Versões revisadas e aprovadas
Garantia de devolutiva do PDI em até 60 dias	Até 60 dias após a avaliação	Data registrada em sistema e assinatura de recebimento pelos pais

1.7 COMUNICAÇÃO ENTRE SUPERVISOR E TERAPEUTAS

A comunicação entre supervisores e terapeutas é um pilar fundamental para a consistência das intervenções. Espera-se que ambos os lados atuem de forma proativa, técnica e colaborativa.



Do **supervisor**, espera-se:

- Disponibilidade para um turno presencial semanal
- Apoio técnico contínuo à equipe
- Respostas assertivas às dúvidas clínicas
- Revisão técnica dos relatórios clínicos
- Direcionamento estratégico da equipe

Da **equipe terapêutica**, espera-se:

Comportamento	Periodicidade	Forma de registro
Apresentar demandas clínicas ao supervisor	Sempre que necessário	Registro no prontuário ou sistema
Solicitar orientação sobre casos	Periódico	Registros de supervisão
Comunicar dificuldades e limitações	Imediato	Registro de reunião ou e-mail
Alinhar-se às diretrizes institucionais	Contínuo	Declaração de ciência e registros de treinamento

1.8 ENCAMINHAMENTOS PARA O NÚCLEO ABA

Quando identificada a necessidade de intensificação da intervenção, o caso pode ser encaminhado ao Núcleo ABA. Esse processo requer documentação formal e etapas bem definidas, conforme descrito abaixo:

Etapas	Responsável	Evidência e produto gerado
Identificação da necessidade de carga intensiva	Terapeuta e equipe	Registro de evolução e atas de reuniões clínicas
Comunicação com os pais	Terapeuta responsável	E-mail, ata de reunião, assinatura de ciência
Encaminhamento à supervisão do Núcleo ABA	Terapeuta responsável	Documento formal de solicitação
Autorização e inclusão no Núcleo	Supervisor do Núcleo ABA	Registro no plano de atendimento



1.9 INDICADORES DE QUALIDADE DO MODELO

Os indicadores de qualidade asseguram que a intervenção clínica esteja alinhada com os parâmetros definidos pelo MAAIS. Eles permitem monitorar a consistência das práticas, a efetividade da supervisão e a satisfação da equipe.

Indicador	Meta	Ferramenta de verificação
Tempo médio para entrega do PDI	≤ 60 dias após a avaliação	Data de entrega registrada no prontuário
Frequência de supervisão por supervisor de área	≥ 1 vez por mês (ideal: 1 vez por semana)	Planilha de supervisão
Satisfação da equipe com a comunicação interna	≥ 80% em pesquisa semestral	Formulário de satisfação
Atualização técnica da equipe	≥ 2 eventos formativos por ano	Certificados e listas de presença

1.10 EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO

A execução da intervenção deve ser guiada pelos princípios técnicos do modelo, considerando o PDI e as diretrizes metodológicas adotadas pela instituição. Abaixo, seguem os passos operacionais esperados de cada profissional no momento da atuação terapêutica:

- Preparar o ambiente e os materiais conforme os objetivos da sessão.
- Implementar os programas terapêuticos conforme o PDI e a diretriz técnica de ensino utilizada, como o Ensino por Tentativas Discretas (Discrete Trial Training – DTT), o Ensino no Ambiente Natural (Natural Environment Teaching – NET), o ensino por encadeamento, ou outra conforme a área de atuação.
- Aplicar estratégias como reforçamento diferencial, uso de *prompts* e *fading* conforme planejamento clínico – recursos aplicáveis a todas as áreas de intervenção.
- Adaptar a intervenção ao contexto em que ocorre (clínico, escolar ou domiciliar), respeitando as particularidades de cada ambiente.



1.11 COLETA DE DADOS E REGISTROS

A coleta sistemática de dados é um pilar do modelo e garante a rastreabilidade, o monitoramento do progresso e a tomada de decisão baseada em evidências. Os registros devem seguir os seguintes critérios:

- Utilizar o sistema SociAutism para inserção de dados em tempo real, especialmente nos casos de ABA intensiva na Área Comportamental.
- Finalizar todos os registros qualitativos e quantitativos até 24 horas após a sessão.
- Realizar, no mínimo, uma gravação semanal (com consentimento) para análise de fidelidade nas intervenções conduzidas por ATs.
- Redigir relatórios semanais que contenham tanto dados objetivos (quantitativos) quanto observações clínicas (qualitativas).

1.12 SUPERVISÃO CLÍNICA

A supervisão clínica é fundamental para garantir a aderência técnica ao modelo, promover o aprimoramento contínuo da equipe e ajustar condutas com base em dados objetivos. Para que esse processo seja efetivo e contribua com a qualidade das intervenções, devem ser observadas as seguintes diretrizes:

- Submeter-se à supervisão direta (mínimo de uma hora por semana) e à supervisão indireta (também com mínimo de uma hora por semana), conforme a carga horária de atendimento, com ênfase especial na Área Comportamental.
- Enviar, com antecedência mínima de 12 horas, os dados coletados, dúvidas clínicas e vídeos de sessões para análise durante a supervisão.
- Participar ativamente das reuniões de análise de gráficos e da tomada de decisões clínicas, contribuindo com reflexões e propostas de ajuste.
- Participar de reuniões mensais interdisciplinares, promovendo a integração entre as diferentes áreas envolvidas no acompanhamento do aprendiz.



1.13 MONITORAMENTO E AJUSTES

O modelo estabelece o monitoramento contínuo dos objetivos terapêuticos como uma diretriz central da prática clínica. A intervenção deve ser ajustada com base na análise sistemática dos dados coletados, garantindo responsividade ao progresso do aprendiz e alinhamento às metas estabelecidas. A seguir, estão as condutas esperadas para assegurar a eficácia desse processo:

- Reunir os dados por meta semanalmente, favorecendo uma visão clara da evolução de cada objetivo.
- Atualizar os critérios de domínio e as estratégias de ensino com base na análise dos dados registrados.
- Documentar todos os ajustes realizados no PDI, assegurando a aprovação prévia do Supervisor de Área.
- Realizar registros qualitativos ao final de cada atendimento, utilizando o sistema clínico adotado pela clínica.

1.14 GENERALIZAÇÃO

A generalização de habilidades é um princípio fundamental na intervenção clínica baseada em evidências. O processo terapêutico só se torna efetivo quando os comportamentos aprendidos são transferidos para ambientes variados e mantidos ao longo do tempo, com diferentes pessoas, estímulos e situações. Para garantir esse processo, são esperadas as seguintes ações:

- Definir os contextos-alvo para a generalização, como casa, escola e outros ambientes significativos para o aprendiz.
- Planejar treinos específicos que envolvam diferentes pessoas, materiais e estímulos, promovendo flexibilidade e autonomia no uso das habilidades.
- Registrar a transferência de habilidades de forma sistemática em relatórios e *checklists* de generalização, assegurando o acompanhamento clínico desse processo.



1.15 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Os documentos listados a seguir devem estar disponíveis para consulta e atualização periódica, assegurando a rastreabilidade dos processos clínicos, o acompanhamento da evolução do aprendiz e a qualidade da tomada de decisão terapêutica:

- PDIs.
- Relatórios semanais de sessão.
- *Checklists* de fidelidade e de generalização.
- Atas de supervisão clínica.
- Gráficos do sistema SociAutism.
- Formulários de prática parental.



REFERÊNCIAS

MOREIRA, Thereza Maria Magalhães; ARAÚJO, Thelma Leite de. O modelo conceitual de sistemas abertos interatuantes e a teoria de alcance de metas de Imogene King. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 10, p. 97-107, 2002.

ZIMERMAN, David E. Atributos desejáveis para um coordenador de grupo. *In*: ZIMERMAN, David E.; OSÓRIO, Luiz Carlos *et al.* **Como trabalhamos com grupos**. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, p. 41-47, 1997.



EQUIPE EDITORIAL

AUTORIA

Fábio Coelho

DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO

Victor Cardoso

EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO

Victor Cardoso

REVISÃO TÉCNICA

Càrol Lèal

CONSULTORES E ESPECIALISTAS

Fábio Coelho

Jenifer Macedo

Maria Christina Souza

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO

Academia do Autismo

REDES SOCIAIS



@maaisacademiadoautismo



@maaisacademiadoautismo



@academiadoautismo



@academiadoautismo

CONTATO



maais@academiadoautismo.com.br



(22) 99216-0282



academiadoautismo.com.br/maais

Este material é protegido por direitos autorais e não pode ser comercializado, distribuído, copiado, editado, alugado, transmitido ou reproduzido, total ou parcialmente, em qualquer meio de comunicação ou distribuição. Permissões para tais ações podem ser concedidas somente mediante autorização expressa do detentor e proprietário dos direitos do material. Qualquer violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Todos os direitos estão reservados à Academia do Autismo Ltda.